

INFORME DE EVALUACIÓN NEUROPSICOLÓGICA

— Variante Profesional —

PACIENTE

Marta Lucía Gómez Vargas

DOCUMENTO

CC 41678901

FECHA NACIMIENTO

12/05/1960

EDAD

66 años, 1 meses

SEXO

Femenino

ESCOLARIDAD

Bachiller Completo

LATERALIDAD

Diestra

FECHA DE EVALUACIÓN

17/06/2026

ORDEN N°

OM-2026-001247

PROTOCOLO APLICADO

Neuronorma Colombia AM + MMSE + GDS-15

INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA

Nombre:	Marta Lucía Gómez Vargas	Lateralidad:	Diestra
Documento:	CC 41678901	Ocupación:	Pensionada (docente)
Fecha de nacimiento:	12/05/1960	Ciudad:	Bogotá, D.C.
Edad:	66 años, 1 meses	Acompañante:	Héctor Gómez Castillo
Sexo:	Femenino	Remite:	Médico familiar
Escolaridad:	Bachiller Completo	EPS / Asegurador:	Sanitas EPS

MOTIVO DE CONSULTA

Control neuropsicológico anual. Jubilada hace 1 año, sin quejas cognitivas subjetivas. Activa socialmente. Antecedente de HTA controlada.

PRUEBAS APLICADAS

Protocolo: Neuronorma Colombia AM + MMSE + GDS-15

Prueba	Dominio	Dur.
TMT A	Atención	—
TMT B	Funciones Ejecutivas	—
Span Retención Dígitos Directo	Memoria de Trabajo	—
Span Retención Dígitos Inverso	Memoria de Trabajo	—
Test de Stroop Palabra	Atención	—
Test de Stroop Color	Atención	—
Test de Stroop Palabra/Color	Atención	—
Fluidez Verbal Animales	Lenguaje - Fluidez	—
Fluidez Verbal Fonémica (P)	Lenguaje	—
AM Deno	Lenguaje	—
AM MRemRec	Memoria	—
Escala de Depresión Geriátrica Yesavage	Socioemocional - Depresión	—
Mini-Mental State Examination (MMSE)	General	—
Escala de Lawton y Brody (IADL)	General	—

ANTECEDENTES

Patológicos / Médicos

Sin antecedentes médicos de relevancia.

Farmacológicos

Sin medicación actual.

Familiares

Sin antecedentes neuropsiquiátricos de primer grado.

Psiquiátricos

Antecedente de trastorno depresivo en tratamiento con sertralina 50 mg/día.

Traumáticos

Niega TEC.

RESUMEN EJECUTIVO

Pirámide invertida: conclusión, hallazgos, implicación

Conclusión

Perfil neuropsicológico global: $Z = -0.4\sigma$ sobre 6 dominios evaluados.

Hallazgos clave

- Memoria moderadamente descendido ($Z=-1.7\sigma$)

Implicación

Se sugiere intervención dirigida al dominio descendido, con monitoreo de respuesta a tratamiento.

OBSERVACIÓN CLÍNICA

Hallazgos cualitativos durante la administración

Apariencia y conducta

Evaluación neuropsicológica completa. Paciente colaborador. Sin incidentes durante la aplicación.

Atención y concentración

Atención sostenida y selectiva preservadas. Desempeño dentro de rangos esperados para edad y escolaridad.

Memoria

Memoria inmediata y de trabajo preservadas. Memoria episódica anterógrada y retrógrada funcionales.

Praxias y gnosias

Sin alteraciones significativas en praxias ni gnosias.

Funciones ejecutivas

Flexibilidad cognitiva, planificación y monitorización preservadas.

Emociones y comportamiento

Sin sintomatología depresiva. Activa, con proyectos personales. Red social preservada.

Cociente intelectual (observación)

Perfil cognitivo global: Z00 - Examen de control (envejecimiento normal)

RESULTADOS CUANTITATIVOS

Puntajes por prueba y perfil cognitivo del paciente

Escala de Depres

2

Normal

Mini-Mental Stat

29

Normal

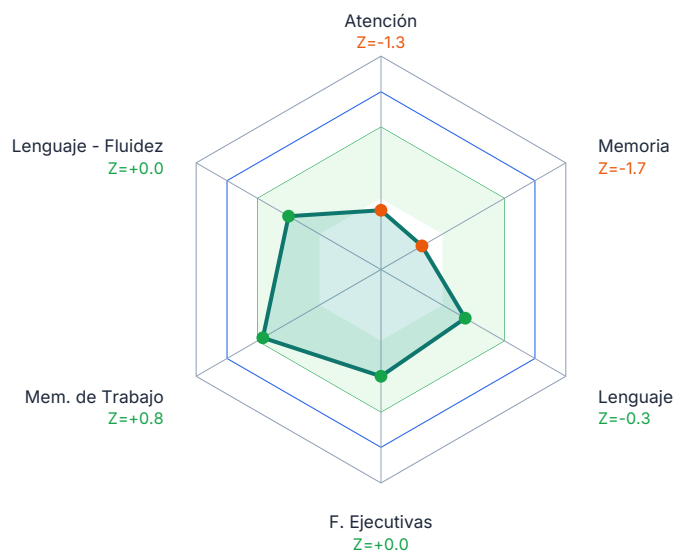
Escala de Lawton

8

Normal

Perfil cognitivo por dominio

Cada eje representa un dominio cognitivo. El polígono teal muestra el Z del paciente; la franja verde central equivale al rango normal (-1 a +1 σ).

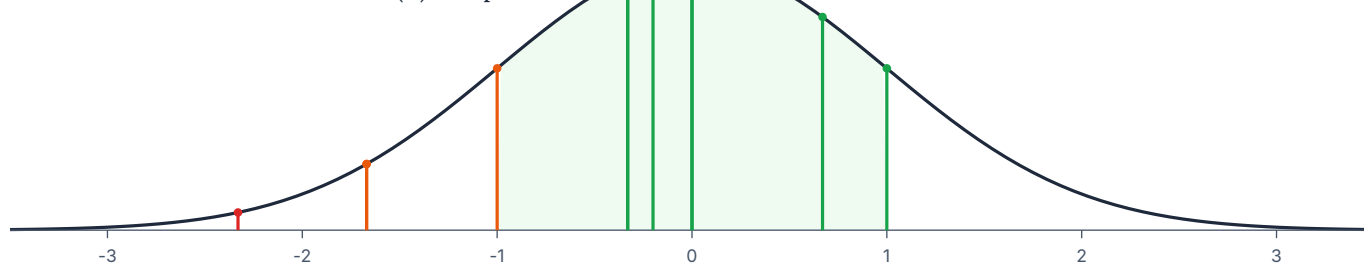


Curva normal con puntajes Z del paciente

Eje horizontal: puntaje Z (unidades de desviación estándar). Las marcas rojas son los puntajes del paciente sobre la curva.

Distribución del rendimiento (Z) del paciente sobre la curva normal estándar

n = 11 pruebas con norma disponible

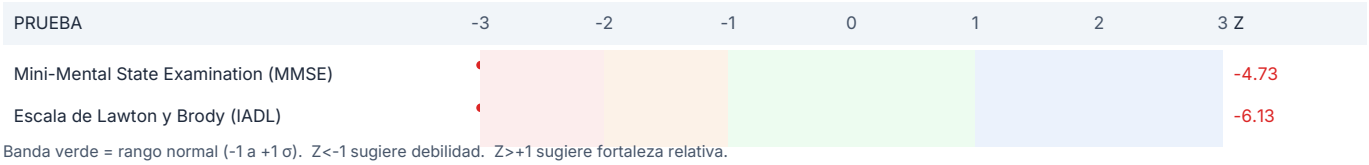


Perfil Z por prueba

Perfil Z por prueba

Eje horizontal: puntaje Z (rango -3 a +3). Verde = zona normal; rojo/naranja = debajo del promedio; azul = por encima.

PRUEBA	-3	-2	-1	0	1	2	3 Z
TMT A							-0.33
TMT B							+0.00
Span Retención Dígitos Directo							+1.00
Span Retención Dígitos Inverso							+0.67
Test de Stroop Palabra							-2.33
Test de Stroop Color							-1.67
Test de Stroop Palabra/Color							-1.00
Fluidez Verbal Animales							+0.00
Fluidez Verbal Fonémica (P)							-0.33
AM Deno							-0.20
AM MRemRec							-1.67
Escala de Depresión Geriátrica Yesavage							-6.53



Semáforo de dominios cognitivos

DOMINIO	Z	BANDA
Memoria	-1.67σ	moderado
Atención	-1.33σ	moderado
Lenguaje	-0.27σ	promedio
Funciones Ejecutivas	+0.00σ	promedio
Lenguaje - Fluidez	+0.00σ	promedio
Memoria de Trabajo	+0.83σ	promedio

Tabla detallada de puntajes

Prueba	PD	Escalar/CI	Z	Interpretación
TMT A	65	9	-0.33	Promedio
TMT B	95	10	+0.00	Promedio
Span Retención Dígitos Directo	6	13	+1.00	Superior
Span Retención Dígitos Inverso	4	12	+0.67	Promedio
Test de Stroop Palabra	45	3	-2.33	Bajo
Test de Stroop Color	38	5	-1.67	Límitrofe
Test de Stroop Palabra/Color	18	7	-1.00	Promedio
Fluidez Verbal Animales	18	10	+0.00	Promedio
Fluidez Verbal Fonémica (P)	14	9	-0.33	Promedio
AM Deno	42	42	-0.20	Promedio
AM MRemRec	8	5	-1.67	Límitrofe
Escala de Depresión Geriátrica Yesavage	2	2	-6.53	Normal
Mini-Mental State Examination (MMSE)	29	29	-4.73	Normal
Escala de Lawton y Brody (IADL)	8	8	-6.13	Normal

SÍNTESIS CLÍNICA INTEGRADORA

Lectura cuantitativa de los hallazgos

El perfil neuropsicológico evidencia debilidades en: memoria (moderadamente disminuido, Z=-1.7); atención (moderadamente disminuido, Z=-1.3).

Entre las pruebas con mayor desviación se encuentran Test de Stroop Palabra (Z=-2.33, bajo); Test de Stroop Color (Z=-1.67, límiterofe); AM MRemRec (Z=-1.67, límiterofe). Estos hallazgos orientan la formulación diagnóstica y la priorización de objetivos de intervención.

Áreas con desempeño disminuido

- Test de Stroop Palabra — bajo (Z=-2.33)
- AM MRemRec — límiterofe (Z=-1.67)
- Test de Stroop Color — límiterofe (Z=-1.67)
- Test de Stroop Palabra/Color — promedio (Z=-1.00)

Áreas con desempeño preservado / superior

- Span Retención Dígitos Directo — superior (Z=+1.00)

RESUMEN PARA LA FAMILIA

Lenguaje sencillo para padres, cuidadores y paciente

Saludo

Este es un resumen de la evaluación que se realizó Marta. Está escrito en un lenguaje sencillo para que sea fácil de entender. Tu psicólogo o psicóloga te explicará los detalles y resolverá cualquier duda que tengas.

¿Qué hicimos en la evaluación?

Realizamos varias pruebas que miden cómo funciona tu cerebro en distintas situaciones: memoria, atención, lenguaje, razonamiento y la velocidad con la que procesas información. Las pruebas son como "pequeños retos" que se resuelven con papel, lápiz y a veces con cubos o figuras. No hay respuestas buenas ni malas: lo que nos interesa es conocer cómo trabaja tu mente.

¿Qué encontramos?

Las áreas donde te fue bien incluyen: En TMT A, tu rendimiento fue dentro del rango esperado. En TMT B, tu rendimiento fue dentro del rango esperado. En Span Retención Dígitos Directo, tu rendimiento fue muy por encima del promedio. Las áreas donde se recomienda trabajar incluyen: En Test de Stroop Palabra, encontramos un rendimiento por debajo del promedio. Es importante que converses con tu psicólogo/a sobre qué significa esto y qué apoyos podrían ayudarte. En Test de Stroop Color, tu rendimiento estuvo en el límite (Límitrofe). Vale la pena acompañarlo de cerca. En ViMRemRec, tu rendimiento estuvo en el límite (Límitrofe). Vale la pena acompañarlo de cerca.

Implicaciones para la vida diaria

Además de los puntajes, esto es lo que podría notarse en la vida cotidiana:

Memoria · moderado

- Recordar listas de pendientes, citas o encargos del día a día.
- Retener información nueva (un nombre, una instrucción, un número telefónico).
- Recuperar recuerdos autobiográficos o eventos recientes.

Apoyos sugeridos: Anotar todo en agenda, app o post-its a la vista. · Repasar información recién aprendida a los 10 minutos, 1 hora y 1 día.

Atención · moderado

- Mantener el foco en una conversación larga (especialmente en reuniones o clases).
- Seguir instrucciones de varios pasos sin perder algún detalle.
- Filtrar estímulos distractores en lugares ruidosos o con mucha gente.

Apoyos sugeridos: Dividir el trabajo en bloques de 20-25 minutos con pausas activas. · Usar temporizadores visuales (Time Timer) y listas de verificación.

Áreas para apoyar (en qué trabajar)

- En TMT A, tu rendimiento fue dentro del rango esperado.
- En TMT B, tu rendimiento fue dentro del rango esperado.
- En Span Retención Dígitos Directo, tu rendimiento fue muy por encima del promedio.
- En Span Retención Dígitos Inverso, tu rendimiento fue dentro del rango esperado.
- En Test de Stroop Palabra/Color, tu rendimiento fue dentro del rango esperado.
- En Test de Stroop Palabra, encontramos un rendimiento por debajo del promedio. Es importante que converses con tu psicólogo/a sobre qué significa esto y qué apoyos podrían ayudarte.
- En Test de Stroop Color, tu rendimiento estuvo en el límite (Límitrofe). Vale la pena acompañarlo de cerca.
- En ViMRemRec, tu rendimiento estuvo en el límite (Límitrofe). Vale la pena acompañarlo de cerca.

¿Qué recomendamos?

Sobre la terapia: continúa con tus sesiones según lo acordado. Si tienes dudas, coméntalas con tu terapeuta.

Preguntas frecuentes

¿Mis resultados son permanentes?

No necesariamente. El cerebro puede cambiar con el tiempo, especialmente con práctica, con los apoyos adecuados y con un buen ambiente. Estos resultados son una foto del momento actual: tu psicólogo/a te ayudará a entender qué puede cambiar y qué se mantiene más estable.

¿Por qué algunos resultados son mejores que otros?

Es completamente normal. Todas las personas tienen áreas donde son más fuertes y áreas donde pueden mejorar. Esto NO significa que haya algo mal: el cerebro humano es diverso y cada uno tiene su propio perfil.

¿Qué significa un puntaje 'bajo' o 'muy bajo'?

Significa que, comparado con personas de la misma edad y nivel educativo, esa función específica rindió por debajo de lo esperado. NO es un diagnóstico en sí mismo. Es una señal para profundizar, entrenar y apoyar esa área. Tu psicólogo/a te explicará si requiere intervención profesional adicional.

¿Qué es el 'cociente intelectual' (CI)?

El CI es un número que resume el rendimiento global en diversas pruebas. NO define tu inteligencia total ni tu valor como persona: es solo una medida parcial de ciertas habilidades de razonamiento, memoria y atención. Varía según el contexto, la fatiga, el ánimo del día y muchos otros factores.

¿Qué hago con las áreas donde me fue muy bien?

¡Celebra y potencia esas fortalezas! Pueden ser tu ancla para compensar las áreas que requieren más esfuerzo. Compartir esto con tu familia, colegio o terapeuta les permite diseñar estrategias que aprovechen lo que mejor te sale.

IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA

DSM-5 / CIE-10

Diagnóstico codificado

Código CIE-10: Z00

Impresión diagnóstica: Z00 - Examen de control (envejecimiento normal)

RECOMENDACIONES

Plan de manejo agrupado por área y prioridad

- Se recomienda seguimiento clínico y plan terapéutico según hallazgos. Reevaluación en 6-12 meses si aplica.

Recomendaciones del cuadro clínico

Banco de recomendaciones clínicas sugeridas para el cuadro identificado. El clínico debe seleccionar las aplicables antes de emitir el informe definitivo.

Desgaste del cuidador · Adulto Mayor (50+ años)

- Aplicar escala de Zarit para cuantificar la carga.
- Psicoeducación sobre el curso de la enfermedad del paciente.
- Psicoterapia de apoyo individual o grupos de cuidadores.
- Red de apoyo: distribuir responsabilidades entre familiares.
- Programa de respiros (cuidadores relevo, centros día).
- Higiene del sueño, alimentación y autocuidado del cuidador.
- Identificar y tratar síntomas depresivos o ansiosos en el cuidador.
- Reconocer señales de alarma: maltrato, negligencia, ideación autolítica.

ANEXO — DEFINICIONES OPERATIVAS

Convenciones interpretativas utilizadas en este informe

Cociente Intelectual (CI)

Puntuación estándar con media 100 y desviación 15. CIT menor a 70 sugiere déficit; 70-79 límite; 80-89 promedio bajo; 90-109 promedio; 110-119 promedio alto; 120-129 superior; ≥ 130 muy superior.

Puntaje escalar (PE)

Subtests Wechsler — media 10, desviación 3. PE de 8-12 equivale al rango promedio.

Puntuación Z

Desvío en unidades de desviación estándar respecto al grupo normativo. $Z = (PD - \mu) / \sigma$. $Z \leq -1$ indica rendimiento bajo el promedio; $Z \leq -2$ indica déficit clínico.

Percentil

Porcentaje de la población normativa con desempeño igual o inferior al del paciente.

Discrepancia significativa

Diferencia entre índices que excede el umbral de Wechsler. Líneas críticas: $p < .15$ (.....) sugieren tendencia; $p < .05$ () indican diferencia confiable.

Reliable Change Index (RCI)

Jacobson-Truax. $RCI > 1.96$ indica cambio confiable ($p < .05$) entre evaluaciones repetidas. Se reporta sólo en informes de seguimiento.